SDD 27 - Sujet n°2

Spécialité : Gériatrie

Date : 02/11/2024
Auteur : Gaëlle Tisserand (DES MPR, EDN 2024)
Relecteur(s) : Eloïse Francq (DES gériatrie 2020), Clément FILLIOL (DES RAI, ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	-
Item(s) en lien avec la station	109 - Troubles de la marche et de l'équilibre 131 - Troubles de la marche et de l'équilibre chez le sujet âgé 133 - Autonomie et dépendance chez le sujet âgé
Situation(s) de départ en lien avec la station	27 - Chute de la personne âgée 31 - Perte d'autonomie progressive
Matériel nécessaire à la station	Compte-rendu des urgences - 2 chaises - 1 table - papier de brouillon - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Identification des facteurs prédisposants et précipitants d'une chute

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de gériatrie.
Vous lisez le compte-rendu des urgences de Mme Kervella, 85 ans, qui a chuté à son domicile et qui va être hospitalisée dans votre service.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- Repérer les principaux facteurs prédisposants de chute chez cette patiente
- Identifier les facteurs précipitants de chute chez cette patiente
- Compléter le bilan de l'urgentiste

Vous ne devez pas :

- Proposer de prise en charge thérapeutique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans PS ni PPS.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
Identifie les facteurs de risque prédisposants de chute :			
1.	Âge ≥ 80 ans	1 point	☐
2.	Sexe féminin	1 point	☐
3.	Antécédent de coxarthrose → trouble de la marche	1 point	☐
4.	Antécédent de cataracte → troubles visuels	1 point	☐
5.	Polymédication (> 5 traitements)	1 point	☐
6.	Iatrogénie : *(point si un des deux éléments)* - Psychotropes par trouble de la vigilance et trouble de l'attention - Antihypertenseurs par hypotension artérielle	1 point	☐
Identifie les facteurs précipitants de chute :			
7.	Met en évidence le globe urinaire	1 point	☐
8.	Met en évidence l'hyponatrémie	1 point	☐
9.	Met en évidence l'anémie microcytaire	1 point	☐
Complète le bilan de l'urgentiste :			
10.	ECG	1 point	☐
11.	Test d'hypotension orthostatique	1 point	☐
12.	Dosage de la vitamine D	1 point	☐
13.	Dosage de l'albumine	1 point	☐
14.	Bilan martial (ou dosage de la ferritine)	1 point	☐
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

15.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

16.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

17.

1. Échelle d'évaluation de performance globale: description générale

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	**Conforme aux attentes**	**Au-delà des attentes**	**Très au-delà des attentes**
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de connaissances ou de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL	**17 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Éléments de rétroaction :

On le sait, les gériatres détestent les chutes « mécaniques » ! Il faut toujours s'efforcer de chercher ce qu'il y a derrière pour éviter que la patiente ne chute à nouveau.

A. Les facteurs favorisants ou facteurs de risque sont les facteurs prédisposant à la chute. Ils représentent une vulnérabilité chronique face au risque de chute. Certains d'entre eux sont évitables ou du moins peuvent être limités, et leur prise en charge permet d'améliorer l'équilibre et la marche, ainsi que de diminuer le risque de chute.

B. Les causes ou facteurs précipitants représentent l'événement aigu responsable de la chute. Ils peuvent être intrinsèques (liés à un facteur médical aigu) ou extrinsèques (liés à l'environnement).

A. Facteurs prédisposants

- Âge ≥ 80 ans
- Sexe féminin
- Antécédents de chutes et de fractures traumatiques
- Trouble dépressif
- Troubles neurocognitifs (voir chapitre sur les troubles neurocognitifs)
- Dénutrition protéino-énergétique (voir chapitre dénutrition)
- Polymédication (> 5 traitements)
- Iatrogénie :
  - Psychotropes par trouble de la vigilance et trouble de l'attention
  - Anticholinergique par trouble de la vigilance/attentionnel
  - Antihypertenseurs par hypotension artérielle
  - Bêta-bloquants, inhibiteur calcique, digoxine par bradycardie
  - Neuroleptiques par syndrome parkinsonien
- Pathologies donnant des troubles de la marche et de l'équilibre
  - Faiblesse musculaire des membres inférieurs (MI)
  - Atteintes neurologiques (vasculaire, dégénérative, hydrocéphalie…)
  - Anomalie des MI, du rachis, des chevilles et des pieds
  - Troubles de la sensibilité superficielle et/ou proprioceptive des MI
- Troubles du sommeil avec possible prise de psychotropes
- Baisse de l'acuité visuelle et/ou altérations périphériques du champ visuel

B. Facteurs précipitants

Ces facteurs représentent l'événement aigu responsable de la chute (tableau). Ils peuvent être intrinsèques (liés à un facteur médical aigu) ou extrinsèques (liés à l'environnement), ou les deux.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

1A. INTRINSÈQUES	
Cardiovasculaires	Troubles du rythme ou de conduction Syndrome coronarien aigu Embolie pulmonaire, Syncope sur rétrécissement aortique serré, syndrome du sinus carotidien, malaise vagal, syncopes situationnelles Hypotension orthostatique
Neurologiques	AVC/AIT, syndrome confusionnel, crise convulsive
Vestibulaires	Vertige, instabilité, nystagmus
Maladies infectieuses	Hyperthermie, hypovolémie, hypoxémie
Métaboliques	Hypoglycémie, hyponatrémie, déshydratation, hypercalcémie
Toxiques	Intoxication alcoolique, sevrage
Iatrogénie	Rechercher l'introduction, l'arrêt ou modification de posologie récente d'un traitement : ● Confusion, hypovigilance : anticholinergique, neuroleptique, ou autre psychotrope ? ● Hypotension orthostatique, bradycardie, syncope : antihypertenseurs, bêta-bloquants, inhibiteur calcique, digoxine ● Déshydratation : diurétiques ?
1B. COMPORTEMENTAUX	
Prise de risque	Lever trop rapide, utilisation d'un escabeau ou un tabouret instable
2. EXTRINSÈQUES	
Environnement inadapté	Éclairage défectueux, sol mouillé, environnement encombré - habillage/chaussage inadapté...

L'indication des examens complémentaires nécessaires à l'évaluation de la gravité d'une chute dépend des différents facteurs analysés dans la démarche et comprenant :

A. Conséquences de la chute
B. Caractère répété de la chute
C. Étiologies de la chute
D. Situations médicales et sociale à risque de complications

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Selon les conséquences de la chute :

- ECG (quasi systématique) en particulier si malaise, perte de connaissance, facteurs de risque cardiovasculaire ou cardiopathie sous-jacente, suspicion ou évaluation de sévérité d'une hyperkaliémie, chute dans des circonstances inconnues
- Radiographies osseuses si suspicion de fracture
- Dosage des CPK et de la créatinine sérique si séjour au sol > 1 heure
- Glycémie si la personne est diabétique
- L'imagerie cérébrale (TDM cérébrale) en urgence n'est indiquée qu'en cas de symptôme neurologique (IRM cérébrale en première intention si suspicion d'AVC et délai thrombolyse ou thrombectomie) ou en cas de traumatisme crânien sous antithrombotique (anticoagulant ou antiplaquettaire)
- En raison de la fréquence des troubles hydroélectrolytiques, de l'anémie, de la déshydratation, les examens biologiques « de routine » seront facilement réalisés, en particulier en l'absence de référence récente

Selon l'étiologie de la chute et les situations à risque de complications :

- ECG, échographie cardiaque, coronarographie en cas de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque, d'infarctus du myocarde
- Imagerie cérébrale en cas d'accident vasculaire cérébral (SDD-121)
- Enquête étiologique d'une pathologie infectieuse
- Glycémie en particulier en cas de traitement par insuline ou antidiabétique oral hypoglycémiant
- Bilan d'hémostase en cas de traitement par anticoagulants
- Dosage sérique de la vitamine D (25OHD) pour le risque fracturaire, et bilan d'une ostéoporose
- La confusion est un fréquent facteur précipitant de chute, son bilan étiologique est une urgence
- Il n'est **pas utile** de réaliser, **à titre systématique**, les examens suivants : HbA1c, EEG, imagerie cérébrale, examen écho-Doppler des artères supra-aortiques, Holter-ECG, échographie cardiaque.
    - ➔ Ces examens ne seront réalisés qu'en fonction des données de l'anamnèse, de l'examen clinique dont l'ECG

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

L'étudiant est seul assis à une table avec le compte rendu des urgences.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ANNEXE
Compte-rendu des urgences de Mme Kervella, 85 ans, née le 17/11/1939

Motif d'admission aux urgences : Chute à domicile

Antécédents :
HTA
RGO
Insuffisance cardiaque
Cataracte
Coxarthrose
Ostéoporose
Dépression il y a 20 ans

Allergie : Pas de connue

Traitement :
Ramipril 5mg 1cp matin
Bisoprolol 2.5 mg 1cp matin
Furosémide 20mg 1cp matin
Omeprazole 20mg 1 cp matin
Paracétamol 500mg si besoin toutes les 8h
Cholécalciférol tous les 3 mois
Escitalopram 5mg 1 cp matin
Zopiclone 7.5 mg au coucher

Mode de vie :
Ancienne enseignante à la retraite, aime jardiner, vit au domicile avec son mari, 2 enfants qui viennent régulièrement les voir. Autonome dans les actes de la vie quotidienne, marche sans aide technique, pas d'aide à domicile.
Pas de tabac, pas d'alcool.

Histoire de la maladie :
Patiente de 85 ans, amenée par les pompiers pour chute à son domicile à 1h du matin avec douleur du poignet droit. Pas de malaise, pas de prodrome, pas de traumatisme crânien.
Mme Kervella a trébuché sur son tapis en se levant pour aller aux toilettes sans allumer la lumière. Elle n'a pas réussi à se relever, mais son mari l'a entendue et l'a aidée donc pas de station prolongée au sol. Pas d'antécédent de chute, pas de modification récente de l'ordonnance.

Examen clinique à l'admission aux urgences :
TA 140/85, FC 70 bpm, FR 15, SaO2 99% en air ambiant, T° 37°C
Glycémie capillaire = 1 g/L

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Neuro : Patiente orientée dans le temps et dans l'espace, hémodynamiquement stable. Pas de déficit sensitivo-moteur, pas d'anomalie des paires crâniennes, pupilles IRS
Cardio : Bruits du cœur réguliers pas de souffle perçu, pas de signe d'insuffisance cardiaque
Pneumo : MV +/+ sans bruit surajouté, pas de toux, eupnéique en air ambiant
Abdo : SDI, pas de trouble du transit, pas de nausée/vomissement
Uro : pas de SFU, voussure sus-pubienne avec matité à la percussion

Examens complémentaires :
Ionogramme :
Sodium (Na+) : 125 mmol/L
Potassium (K+) : 4,1 mmol/L
Chlore (Cl-) : 96 mmol/L
Bicarbonates (HCO3-) : 24 mmol/L
Calcium (Ca2+) : 2,3 mmol/L
Urée : 4,5 mmol/L
Créatinine : 85 µmol/L

CRP < 1 mg/L

NFS :
Hémoglobine (Hb) : 9,5 g/dL
Hématocrite (Ht) : 30 %
VGM (Vol. globulaire moyen) : 72 fL
CCMH (Conc. corpusculaire moyenne en Hb) : 30 g/dL
Leucocytes : 6 500 /mm^3
Plaquettes : 250 000 /mm^3

Conclusion :
Patiente de 85 ans, admise pour chute à son domicile. Pose d'une sonde à demeure.
Hospitalisation en gériatrie.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)